



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Ofício SMS nº 19459/2026

Considerando a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência do surto de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB) na República Democrática do Congo e em Uganda, bem como a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, detecção precoce, notificação e resposta oportuna a eventos de relevância para a saúde pública;

Considerando a publicação da Nota Técnica Conjunta nº 160/2026/SVSA/SAES/MS, do Ministério da Saúde, que estabelece orientações para definição de caso, manejo clínico, investigação epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos de DVB no território nacional;

Considerando a importância da preparação dos serviços de saúde para identificação e manejo adequado de casos suspeitos da Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB), visando à redução do risco de transmissão e à adoção tempestiva das medidas de prevenção e controle;

A Superintendência de Vigilância em Saúde por meio da Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS), torna público Ofício SMS nº 19459/2026 contendo a Nota Técnica que dispõe sobre as orientações frente a casos suspeitos de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB) no contexto da Emergência de Saúde Pública Internacional.

Reforçamos a necessidade de divulgação às Unidades de Atenção Primária a Saúde, Divisões de Vigilância em Saúde, Responsáveis Técnicos, Médicos e de Enfermagem, além de outros pontos da rede de atenção à saúde envolvidos no tema. Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Caio Luiz Pereira Ribeiro
Coordenador II
Matrícula: 321.947-4
S/SUBPAV/SVS/CIEVS

Gislani Mateus Oliveira Aguiar
Superintendente
Matrícula: 295.268-7
S/SUBPAV/SVS



Documento assinado eletronicamente por **CAIO LUIZ PEREIRA RIBEIRO, Coordenador II**, em 03/06/2026, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



Documento assinado eletronicamente por **GISLANI MATEUS OLIVEIRA AGUIAR, Superintendente**, em 03/06/2026, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 26 do [Decreto Rio nº 57.250, de 19 de novembro de 2025](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://prefeitura.sei.rio/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0&cv=4642001&crc=C5FFB245, informando o código verificador **4642001** e o código CRC **C5FFB245**.



Nota Técnica S/SUBPAV/SVS

Orientações frente a casos suspeitos de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB) no contexto da Emergência de Saúde Pública Internacional

1. ASSUNTO

Trata-se de Nota Técnica contendo definição de caso, orientações para o manejo de casos suspeitos e contactantes, bem como orientações para investigação epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB), no contexto da Emergência de Saúde Pública Internacional relacionada à DVB na República Democrática do Congo e Uganda.

As orientações contidas nesta Nota Técnica poderão ser revisadas e atualizadas conforme a evolução do cenário epidemiológico e a disponibilidade de novas evidências científicas.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em maio de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada sobre um surto de doença desconhecida com elevada letalidade na zona de saúde de Mongbwalu, província de Ituri, na República Democrática do Congo (RDC), incluindo ocorrência de óbitos entre profissionais de saúde. Em 15 de maio de 2026, o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica de Kinshasa confirmou a circulação do vírus Bundibugyo em amostras analisadas, sendo declarado oficialmente o 17º surto de doença pelo vírus Ebola no país.

Até 01 de junho de 2026, foram confirmados 344 casos de DVB e 60 óbitos entre os casos confirmados na República Democrática do Congo, distribuídos em três províncias: Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul. Em 15 de maio de 2026, Uganda confirmou o primeiro caso importado proveniente da RDC em um homem que evoluiu para óbito em Kampala. Até 02 de junho de 2026, foram identificados 15 casos confirmados no país, todos importados ou relacionados à importação. Até o momento, não há evidências de transmissão comunitária na Uganda.

Em 17 de maio de 2026, a OMS declarou que o evento constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), conforme o Regulamento Sanitário Internacional (RSI, 2005). A avaliação da OMS considera que o risco desse evento é muito alto a nível nacional na República Democrática do Congo, alto na região africana e baixo a nível global. Nesse contexto, o Brasil ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, passando da fase de normalidade para a fase de mobilização.

Em 30 de maio de 2026, o CIEVS Rio de Janeiro recebeu comunicação de um viajante belga que chegou de Uganda para a cidade do Rio de Janeiro com quadro clínico leve e compatível com algumas possíveis doenças infecciosas. Após investigação conjunta entre a SMS-RJ, SES-RJ e INI-FIOCRUZ, o caso foi descartado laboratorialmente para Ebola e confirmado para Malária.

Até a data de divulgação desta Nota Técnica, não há casos suspeitos ou confirmados da Doença pelo Vírus Bundibugyo no Brasil.

3. HISTÓRICO

O vírus Bundibugyo é uma espécie do vírus Ebola identificado pela primeira vez em 2007, em Uganda. Embora seja menos frequente que as espécies Zaire e Sudão, também é capaz de causar surtos graves com elevadas taxas de letalidade. Esse é o 3º surto registrado pela espécie. O primeiro surto ocorreu em 2007, no distrito de Bundibugyo, em Uganda, com 149 casos confirmados e 37 óbitos. O segundo foi registrado em 2012, na Província Oriental (atual Ituri), na República Democrática do Congo, totalizando 38 casos e 13 óbitos.



4. INFORMAÇÕES SOBRE O VÍRUS BUNDIBUGYO

A espécie Bundibugyo (*Orthoebolavirus bundibugyoense*) do vírus Ebola (gênero *Orthoebolavirus*) causa uma doença grave com letalidade observada de 30% a 50% em surtos anteriores. A transmissão ocorre por contato direto com sangue, secreções ou fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, bem como por superfícies contaminadas (fômites). O período de incubação varia entre 2 e 21 dias, sendo que, em geral, a transmissibilidade ocorre após o surgimento dos sintomas. Os sintomas iniciais são inespecíficos e incluem febre, fadiga, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta. Com a progressão da doença, podem surgir manifestações gastrointestinais, disfunção orgânica e, em alguns casos, manifestações hemorrágicas. Até o momento, não existem vacinas autorizadas ou tratamento específico para o vírus Bundibugyo.

5. DEFINIÇÃO DE CASO E DE CONTACTANTE

Atualmente, conforme estabelecido na [Nota Técnica Conjunta nº 160/2026/SVSA/SAES/MS](#), do Ministério da Saúde, devem ser consideradas as seguintes definições de caso:



CASO SUSPEITO

- **Caso suspeito:** indivíduo que, nos últimos 21 dias antes do início dos sintomas, tenha permanecido, residido ou viajado para local com transmissão ativa da doença causada pelo vírus Bundibugyo, reconhecido pela OMS, ou tenha histórico de viagem proveniente de país com circulação do vírus, quando não for possível determinar com segurança os locais visitados durante a estadia, e que apresente febre e/ou calafrios, podendo estar acompanhados de diarreia, vômitos ou manifestações hemorrágicas, como diarreia sanguinolenta, gengivorragia, enterorragia, sinais purpúricos ou hematúria.



CASO CONFIRMADO

- **Caso confirmado:** caso suspeito com resultado laboratorial positivo para vírus Bundibugyo, por Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) ou sequenciamento genético viral realizado em laboratórios de referência definidos pelo Ministério da Saúde.



CASO DESCARTADO

- **Caso descartado:** caso suspeito com resultado laboratorial negativo para vírus Bundibugyo realizado em Laboratório de Referência definido pelo Ministério da Saúde. Quando a coleta da primeira amostra ocorrer antes de 72 horas do início dos sintomas, deverá ser realizada uma segunda coleta após esse período, sendo necessário resultado negativo em ambas as amostras para o descarte do caso.



CONTACTANTE OU COMUNICANTE

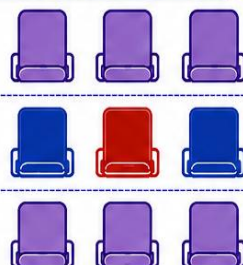
- **Contactante ou Comunicante:** indivíduos assintomáticos que tiveram contato direto ou indireto com caso suspeito ou confirmado de DVB durante o período sintomático da doença, inclusive após óbito.
- **Contato direto:** refere-se ao contato com fluidos ou secreções corporais do caso.
- **Contato indireto:** refere-se à permanência no mesmo ambiente e/ou ao contato com objetos ou superfícies compartilhados com o caso, sem comprovação de exposição aos seus fluidos corporais, incluindo profissionais de saúde que realizaram assistência ao paciente sem relato de exposição direta.



SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DURANTE O VOO



Em caso de exposição durante o voo, consideram-se contactantes os passageiros sentados na mesma fileira do caso suspeito, bem como aqueles alocados na fileira **imediatamente à frente** e na fileira **imediatamente atrás** do caso suspeito.



Passageiros alocados na fileira **imediatamente à frente** e na fileira **imediatamente atrás** do caso suspeito.



Passageiros sentados na mesma fileira do caso suspeito.



Caso suspeito/confirmado.

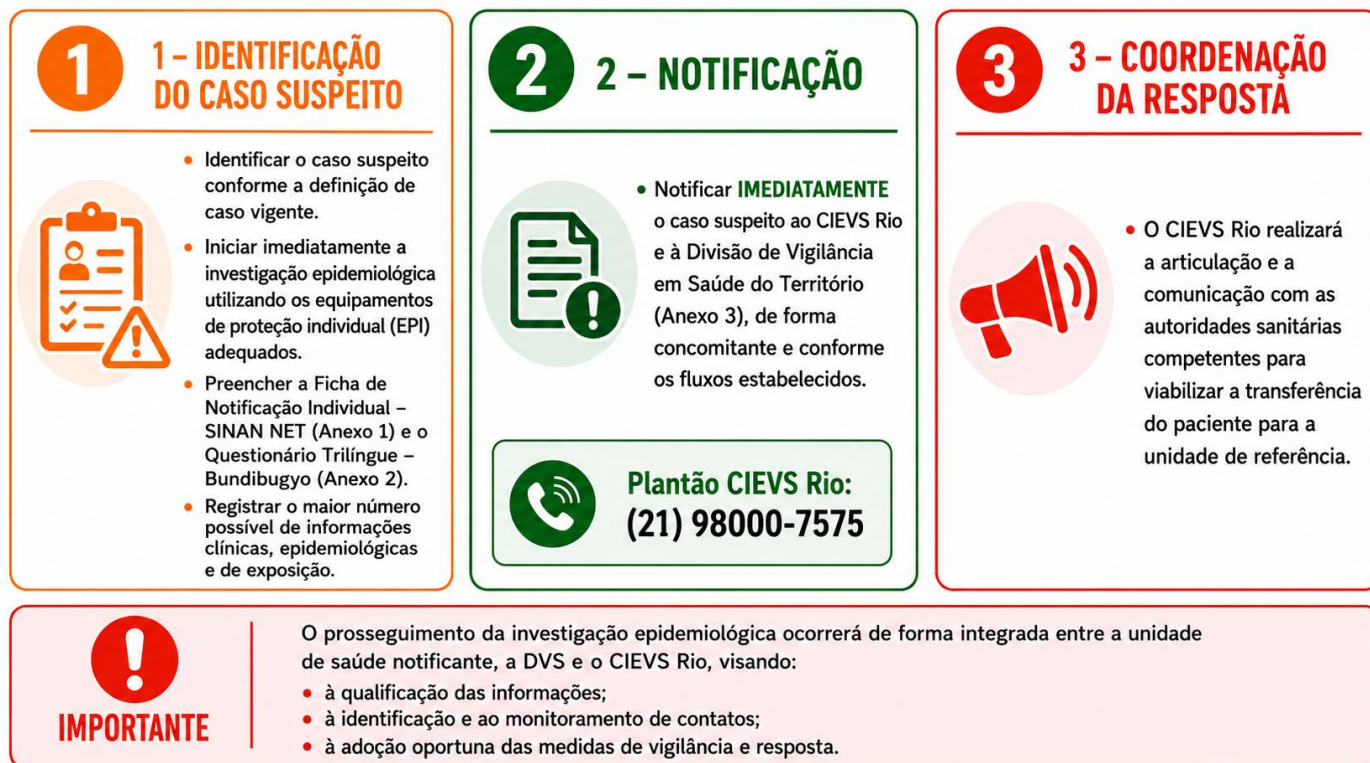
Fonte: NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 160/2026/SVSA/SAES/MS, 2026.



6. NOTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Ebola é uma doença de notificação compulsória imediata. A notificação de todo caso suspeito ou confirmado deve ser realizada pelo profissional de saúde ou pelo serviço que prestar o primeiro atendimento ao paciente ou pela Divisão de Vigilância em Saúde, pelo meio mais rápido disponível, de forma imediata ao CIEVS Rio: (21) 98000-7575/cievs.rio@gmail.com.

A notificação oportuna permitirá o acionamento das autoridades sanitárias responsáveis pela vigilância e investigação epidemiológica e laboratorial dos casos e implementação das medidas adequadas de prevenção e controle.



Fonte: NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 160/2026/SVSA/SAES/MS, 2026.



7. MANEJO INICIAL DE CASO SUSPEITO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

Os serviços de saúde, públicos ou privados, que atuam como porta de entrada assistencial, tais como Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), prontos-socorros, policlínicas ou similares, poderão ser procurados por pessoas que atendam os critérios de definição de caso suspeito ou confirmado de DVB. As principais ações a serem adotadas incluem:

1 1- RECONHECER Reconhecer oportunamente sinais e sintomas compatíveis com DVB, como febre, calafrios, fraqueza, vômitos, diarreia e manifestações hemorrágicas em pessoas com histórico de viagem recente para áreas com circulação do vírus Bundibugyo ou contato com casos suspeitos ou confirmados da doença.	2 2- ISOLAMENTO - Realizar imediatamente o isolamento do paciente, em local privativo com banheiro e porta fechada - Evitar qualquer contato, procedimento ou manipulação que não seja absolutamente essencial.	3 3- EQUIPE Definir a equipe que atenderá o paciente, restrita a um número mínimo de profissionais.	4 4- PARAMENTAÇÃO Paramentar a equipe assistencial, conforme as orientações descritas no item 8 – Medidas de Controle de Infecção desta Nota Técnica, de acordo com o procedimento a ser realizado e o protocolo vigente da unidade de saúde.	5 5- ENTREVISTA Realizar entrevista com caso suspeito (ver Anexo 2).
6 6- NOTIFICAÇÃO Realizar notificação imediata do caso suspeito ao: - CIEVS Rio Plantão CIEVS Rio - (21) 98000-7575 - DVS do território (anexo 3)	7- IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO Identificar e registrar nome completo, tipo de exposição e telefone de todos os indivíduos que atendam à definição de contactante ou comunicante, incluindo familiares, equipe de transporte, profissionais da recepção, dentre outros, e encaminhar a listagem à DVS e ao CIEVS Rio para monitoramento por 21 dias.	8- TRANSFERÊNCIA A equipe CIEVS Rio, após ser acionada, entrará em contato com a equipe do CIEVS SES-RJ, a qual acionará a equipe do SAMU para realizar a transferência do paciente até a unidade de referência estadual (INI/Fiocruz).	9- LIMPEZA TERMINAL A limpeza terminal do ambiente deverá ser feita imediatamente após a saída do caso suspeito; os trabalhadores responsáveis deverão usar os mesmos EPIs da equipe de atendimento e deverá ser realizada desinfecção rigorosa de superfícies e materiais.	10- EXAMES E RESÍDUOS A realização dos exames laboratoriais ocorrerá nos hospitais de referência. Todos os resíduos gerados pelo atendimento, incluindo EPIs, devem ser descartados em sacos de lixo infectante, classificados como Grupo A1 e associados a agentes biológicos de Classe de Risco 4.

IMPORTANTE

- As ações devem ser realizadas com estrito cumprimento das normas de biossegurança e dos protocolos institucionais vigentes.
- A notificação imediata e as medidas de controle precoce são fundamentais para a proteção da equipe de saúde e da comunidade.

IMPORTANTE

Todas as amostras de casos com suspeita de infecção pelo vírus Bundibugyo no município do Rio de Janeiro deverão ser coletadas **EXCLUSIVAMENTE** no **INI/Fiocruz**.

Não realizar coleta de sangue, swab ou qualquer outro material biológico **em outras unidades de atenção à saúde**.

Para maiores informações sobre coleta e transporte de amostras para diagnóstico laboratorial, consultar a [Nota Técnica Conjunta nº 160/2026/SVSA/SAES/MS](#).

8. MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

Aos profissionais envolvidos na assistência direta ou indireta a pacientes com suspeita ou confirmação de DVB, incluindo aqueles envolvidos na remoção e transporte, orienta-se o cumprimento rigoroso de todas as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar conforme as normativas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

As unidades de saúde devem promover o treinamento contínuo das equipes envolvidas na assistência, vigilância e resposta, incluindo realização periódica de simulações de atendimento, capacitação em biossegurança e uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da atualização permanente dos protocolos clínicos e fluxos operacionais segundo rotina com as áreas técnicas correspondentes.

Deve-se manter o registro de todos os profissionais que prestarem assistência direta ou acessarem quartos e áreas assistenciais de pacientes com suspeita ou diagnóstico de febre hemorrágica viral.

Os profissionais de saúde envolvidos na assistência e profissionais da limpeza da área onde o caso suspeito estiver isolado/atendido deverão utilizar os seguintes EPIs:



O processo de paramentação e desparamentação deverá ser realizado de forma supervisionada, tendo o observador o objetivo de verificar se não há áreas de pele ou mucosas descobertas durante a paramentação e se não houve contato entre a parte externa dos EPIs e pele ou muco as durante a desparamentação.

9. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS SUSPEITOS E CONTACTANTES OU COMUNICANTES

A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a identificação de um caso suspeito, incluindo histórico de viagem, possíveis exposições e identificação de contactantes ou comunicantes. A detecção precoce de casos suspeitos e contactantes é fundamental para o desencadeamento oportuno das ações de vigilância, assistência e resposta, visando interromper a cadeia de transmissão na eventual introdução da doença causada pelo vírus Bundibugyo no país.

Nesse contexto, os profissionais da assistência, vigilância em saúde e os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE), no âmbito da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (RENAVEH), possuem papel estratégico na identificação, notificação imediata e monitoramento dos casos suspeitos, devendo atuar de forma articulada com as equipes assistenciais, Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), serviços laboratoriais e gestão hospitalar.

Ações de monitoramento dos contactantes:

- O monitoramento deverá ser realizado por 21 dias a partir da data da última exposição ao caso suspeito, ou até o descarte da doença no caso em investigação.
- O monitoramento deverá ser realizado diariamente. Caso necessário, deverá ser realizada visita domiciliar. Durante a visita, o profissional de saúde deverá utilizar precauções padrão quando o contactante estiver assintomático. Caso haja relato ou observação de sintomas compatíveis com a doença em investigação, deverá ser adotado o uso de EPI completo, conforme protocolo vigente.
- Orientar o contactante sobre os sinais e sintomas da doença, a necessidade de aferição diária da temperatura corporal e a não necessidade de permanecer em quarentena enquanto assintomático. Recomendar que evite viagens e aglomerações durante o período de monitoramento.
- Iniciar imediatamente o isolamento do contactante que apresentar qualquer sinal ou sintoma compatível com a doença, com comunicação imediata ao CIEVS Rio.



- O monitoramento deverá ser realizado por meio da plataforma Go.Data, com o registro do acompanhamento diário dos contatos, sob coordenação do CIEVS Rio e apoio das Unidades de Resposta Rápida (URR).

Os NHE e CCIH devem manter comunicação ativa com a vigilância epidemiológica local e o CIEVS Rio diante da identificação de casos suspeitos, exposições ocupacionais, eventos inusitados ou óbitos suspeitos relacionados às febres hemorrágicas virais e podem colaborar no monitoramento de contatos entre profissionais de saúde de sua instituição.

10. RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VIAJANTES

Considerando as recomendações vigentes da OMS, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e ANVISA, não há indicação de restrições a viagens, fechamento de fronteiras ou medidas relacionadas ao comércio internacional em decorrência da circulação do vírus Bundibugyo. Entretanto, recomenda-se, o fortalecimento das medidas de vigilância, prevenção e orientação aos viajantes provenientes ou com destino às áreas afetadas.

Para viajantes com histórico recente de permanência ou trânsito em áreas com transmissão da doença causada pelo vírus Bundibugyo, recomenda-se atenção à ocorrência de sinais e sintomas compatíveis com febres hemorrágicas virais por até 21 dias após a saída da área afetada.

Em caso de sintomas suspeitos para DVB, comunicar imediatamente o Plantão CIEVS Rio para orientações.

Para viajantes com destino às áreas afetadas, recomenda-se:

- Buscar e seguir as orientações das autoridades sanitárias locais;
- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica;
- Evitar contato com pessoas doentes, especialmente com sangue, secreções e outros fluidos corporais;
- Evitar contato com cadáveres e participação em funerais;
- Evitar contato com animais silvestres, especialmente morcegos e primatas não humanos, bem como com sangue, fluidos corporais ou carne crua desses animais;
- Evitar compartilhar informações não verificadas que possam gerar desinformação, estigmatização ou discriminação de populações e viajantes.

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

Conforme o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, todos os casos suspeitos de DVB serão encaminhados para os Hospitais de Referência Nacional (Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas - Fiocruz, Rio de Janeiro e Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo-SP) tão logo seja possível seu transporte. Assim, é fundamental acionar imediatamente o CIEVS Rio de Janeiro para ativação dos fluxos de comunicação e articulação necessários à transferência do paciente.

O vírus Ebola é classificado como Agente Biológico Classe de Risco 4 (CR-4) exigindo rigorosas medidas de contenção e biossegurança. A transferência deverá observar os fluxos assistenciais previamente pactuados entre os componentes da Rede de Atenção à Saúde (RAS) para os casos de febre hemorrágica viral (FHV).

As equipes avançadas de transporte terrestre do SAMU 192 ou bombeiros, designadas para essas operações deverão possuir treinamento específico e atualizado em biossegurança aplicada a agentes biológicos de alta consequência, prevenção e controle de infecções, utilização correta dos EPI, técnicas de paramentação e desparamentação, limpeza e descontaminação de veículos e equipamentos, gerenciamento de resíduos, manejo clínico inicial de pacientes com Febres Hemorrágicas Virais e reconhecimento de exposições ocupacionais.

Os corpos de pessoas falecidas com suspeita ou confirmação de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB) devem ser considerados potencialmente infectantes e manejados de acordo com rigorosas medidas de biossegurança. O preparo do corpo para o sepultamento deve ser realizado no hospital de referência responsável pelo atendimento do caso e, excepcionalmente, em outro serviço de saúde previamente orientado quanto às medidas de biossegurança.



Todos os procedimentos devem ocorrer no próprio quarto de isolamento, evitando-se a transferência para necrotérios ou morgues.

A manipulação do corpo deve ser restrita ao mínimo necessário e realizada exclusivamente por profissionais treinados e devidamente paramentados com os EPIs recomendados. Não devem ser realizados procedimentos que aumentem o risco de exposição a fluidos corporais, incluindo lavagem do corpo, embalsamamento, tanatopraxia, maquiagem, vestimenta para exibição ou qualquer outra técnica de preparação estética.

Outras informações poderão ser verificadas na [NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 160/2026/SVSA/SAES/MS](#), como:

- Manejo de caso suspeito em portos, aeroportos, fronteiras;
- Manejo de caso suspeito em hospitais nacionais de referência;
- Transporte terrestre de paciente para hospital de referência nacional;
- Transporte aéreo de paciente para hospital de referência nacional e;
- Manejo de cadáveres.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. **Nota Técnica Conjunta Nº 160/2026/SVSA/SAES/MS: contém definição de caso, orientações para o manejo de casos suspeitos e contactantes identificados nos pontos de entrada ou serviços de saúde, bem como orientações para investigação epidemiológica e laboratorial de casos suspeitos de doença pelo vírus Bundibugyo (DVB), no contexto da Emergência de Saúde Pública Internacional relacionada à DVB na República Democrática do Congo e Uganda.** Brasília: Ministério da Saúde, 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Plano de contingência nacional para febres hemorrágicas virais.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: Ministério da Saúde. Acesso em: 20 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde.** 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. **Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional relacionada à doença causada pelo vírus Bundibugyo na República Democrática do Congo e em Uganda: implicações para as Américas.** 21 de maio de 2026.

WHO. World Health Organization. **Disease Outbreak News: Ebola disease caused by Bundibugyo virus, Democratic Republic of the Congo & Uganda 2026.** Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON602> . Acesso em: 20 maio 2026.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – **Ebola Disease: Current Situation. Ebola disease: current situation.** Atlanta: CDC, 2026. Disponível em: <https://www.cdc.gov/ebola/situation-summary/index.html>. Acesso em: 30 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Regulamento Sanitário Internacional (2005).** Brasília: Ministério da Saúde, 2009.



ANEXOS

Anexo 1. Ficha Individual de Notificação - SINAN

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº
FICHA DE NOTIFICAÇÃO				
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	1 - Negativa 2 - Individual 3 - Surto 4 - Inquérito Tracoma ☐		
	2 Agravado/doença	3 Data da Notificação		
	4 UF	5 Município de Notificação	Código (IBGE)	
	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código	7 Data dos Primeiros Sintomas	
Notificação Individual	8 Nome do Paciente	9 Data de Nascimento		
	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	11 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	12 Gestante 1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre 3-3ºTrimestre 4- Idade gestacional Ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado	13 Raça/Cor 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado
	14 Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica			
	15 Número do Cartão SUS	16 Nome da mãe		
	17 Data dos 1ºs Sintomas do 1º Caso Suspeito	19 Local Inicial de Ocorrência do Surto 1 - Residência 2 - Hospital / Unidade de Saúde 3 - Creche / Escola 4 - Asilo 5 - Outras Instituições (alojamento, trabalho) 6- Restaurante/ Padaria 7 - Eventos 8 - Casos Dispersos no Bairro 9- Casos Dispersos Pelo Município 10 - Casos Dispersos em mais de um Município 11 - Outros Especificar		
Dados de Residência	20 UF	21 Município de Residência	Código (IBGE)	22 Distrito
	23 Bairro	24 Logradouro (rua, avenida,...)		Código
	25 Número	26 Complemento (apto., casa, ...)		27 Geo campo 1
Notificante	28 Geo campo 2	29 Ponto de Referência		30 CEP
	31 (DDD) Telefone	32 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	33 País (se residente fora do Brasil)	
	Município/Unidade de Saúde			
Nome		Função	Assinatura	

Notificação

Sinan NET

SVS

17/07/2006

**DADOS COMPLEMENTARES**

(ANOTAR TODOS OS DADOS DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO)

Notificação Individual	01	Data da coleta da 1ª amostra da sorologia	02	Data da coleta da 1ª amostra de outra amostra	03	Especificar tipo de exame :					
	04	Óbito ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado			05	Contato com caso semelhante ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado					
	06	Presença de exantema ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	07	Data do início do exatema	08	Presença de petéquias ou sufusões hemorrágicas ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado					
	09	Foi realizado líquor ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	10				Resultado da bacterioscopia :				
	11	O paciente tomou vacina contra agravo notificado neste impresso? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	12	Data da última dose tomada	13	Ocorreu hospitalização ? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	14	Data da hospitalização			
Notificação Surto	15	UF	16	Município do hospital	Código (IBGE)		17	Nome do hospital	Código		
	18								Hipóteses diagnósticas no momento da notificação 1ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____ 2ª Hipótese Diagnóstica - CID 10: _____		
Local prov. infecção	19								Local provável de infecção (classificação provisória)		
	País: _____				UF		Município: _____				
Distrito: _____								Bairro: _____			

Dados Complementares/ Notificação

SVS 17/07/2006



Anexo 2. Questionário trilingue - Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB)

INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À DOENÇA PELO VÍRUS BUNDIBUGYO
INVESTIGATION OF EVENTS RELATED TO BUNDIBUGYO VIRUS DISEASE
ENQUÊTE SUR LES ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA MALADIE VIRALE DE BUNDIBUGYO

Entrevistador(a) / Interviewer / Intervieweur: _____

Data da entrevista / Date of interview / Date de l'entretien: ____/____/____

Nome do entrevistado / Name / Nom: _____

Grau de parentesco ou vínculo / Relationship-Link / Degré de parenté-Lien: _____

Telefone / Telephone / Téléphone: _____

1. Nome / Name / Nom

2. Endereço / Address / Adresse

3. Município de residência ou permanência / Municipality / Municipalité de residence

4. Data de nascimento / Date of birth / Date de naissance

5. Passaporte/ Passport/ Passeport

6. Sexo / Gender / Sexe

7. Ocupação / Occupation / Occupation

8. Se profissional de saúde, local de trabalho / If health professional, place of work / Professionnel de santé, lieu de travail

9. Quando começou a doença? Início dos sintomas / When did the disease begin? / Apparition des symptoms

10. Local provável de exposição ao vírus Bundibugyo (local onde ocorreu a possível transmissão):
Probable place of exposure to Bundibugyo virus (location where transmission may have occurred):
Lieu probable d'exposition au virus Bundibugyo (lieu où la transmission a pu se produire):

País / Country / Pays: _____

Estado/Província / State/Province / État/Province: _____

Município/Cidade / Municipality/City / Municipalité/Ville: _____

Região/Distrito / Region/District / Région/District: _____

Local específico (aldeia, bairro, comunidade, fazenda, floresta, unidade de saúde, outro) / Specific location (village, neighborhood, community, farm, forest, health facility, other) / Lieu spécifique (village, quartier, communauté, ferme, forêt, établissement de santé, autre):



11. Atividade realizada no local / Activity performed at the location / Activité exercée sur le site

12. Você foi exposto a alguma das seguintes situações nos últimos 21 dias antes do início dos sintomas? (Marque todas as opções aplicáveis)/Were you exposed to any of the following situations during the 21 days before symptom onset? (Check all that apply)/ Avez-vous été exposé(e) à l'une des situations suivantes au cours des 21 jours précédant l'apparition des symptômes ? (Cochez toutes les réponses applicables)

() Contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de caso suspeito ou confirmado de doença pelo vírus Bundibugyo./ Direct contact with blood, tissues, or bodily fluids of a suspected or confirmed Bundibugyo virus disease case./ Contact direct avec du sang, des tissus ou des fluides corporels d'un cas suspect ou confirmé de maladie à virus Bundibugyo.

() Contato com superfícies, roupas, utensílios ou outros objetos contaminados por caso suspeito ou confirmado./ Contact with surfaces, clothing, utensils, or other objects contaminated by a suspected or confirmed case./ Contact avec des surfaces, vêtements, ustensiles ou autres objets contaminés par un cas suspect ou confirmé.

() Participação em funeral, cerimônia fúnebre ou preparação do corpo de caso suspeito ou confirmado./Participation in a funeral, burial ceremony, or body preparation of a suspected or confirmed case./ Participation à des funérailles, à une cérémonie funéraire ou à la préparation du corps d'un cas suspect ou confirmé.

() Contato com animais doentes e/ou mortos./ Contact with sick and/or dead animals./ Contact avec des animaux malades et/ou morts.

() Visita a hospital, unidade de saúde ou centro de tratamento./ Visit to a hospital, healthcare facility, or treatment center./ Visite dans un hôpital, un établissement de santé ou un centre de traitement.

() Foi hospitalizado / Hospitalization/ Hospitalisation.

() Contato com outras pessoas após o início dos sintomas./ Contact with other people after symptom onset./ Contact avec d'autres personnes après l'apparition des symptômes.



LISTA DE CONTATOS E/OU CONTACTANTES DO CASO SUSPEITO

	NOME / NAME / NOM	TELEFONE / PHONE/ TÉLÉPHONE	ENDEREÇO / ADDRESS / ADRESSE	RELAÇÃO COM O SUSPEITO/ RELATIONSHIP TO SUSPECT/ RELATION AVEC LE SUSPECT	DATA DO CONTATO /DATE OF CONTACT/ DATE DU CONTACT	TIPO* DE CONTATO /TYPE OF CONTACT* /TYPE DE CONTACT*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

Físico, mesmo ambiente, dormiu no mesmo quarto, dormiu na mesma cama, manipulou amostra do suspeito, fluidos e secreções, objetos contaminados, etc.

* Physical, same environment, slept in the same room, slept in the same bed, handled sample of the suspected case, fluids and secretions, contaminated objects etc.

* Physique, même environnement, dormi dans la même chambre, dormi dans le même lit, manipulé l'échantillon des suspects, des sécrétions et des fluides, des objets contaminés, etc.



Anexo 3. Lista de contatos das Divisões de Vigilância em Saúde do Município do Rio de Janeiro.

Divisão de Vigilância em Saúde por território de abrangência

AP	Endereço	E-mail
1.0	R. Evaristo da Veiga, 16 - Centro	dvs.cap10@gmail.com
2.1	Av. Venceslau Brás, 65 - Botafogo	vigepidemio.cap21@gmail.com
2.2	Rua Conde de Bonfim, 764 - Tijuca	dvs.cap22@gmail.com
3.1	Rua São Godofredo, 59 - Penha	vigepidemio.cap31@gmail.com
3.2	Rua Aquidabã, 1037 - Lins de Vasconcelos	dvs.cap32@gmail.com
3.3	Rua Manoel Martins, 53 - Madureira	dvscap33@gmail.com
4.0	Av. Ayrton Senna, 2001 Bloco C - Barra da Tijuca	dvs.cap40@gmail.com
5.1	Av. Carlos Pontes s/n - Sulacap	dvscap51@gmail.com
5.2	Rua Campo Grande 120 - Campo Grande, RJ	vigilanciaemsaude52@gmail.com
5.3	Rua Álvaro Alberto, 601 - Santa Cruz	dvs.cap53@gmail.com



Anexo 4. Fluxograma de manejo inicial de caso suspeito de Doença pelo Vírus Bundibugyo (DVB) - Ebola em serviços de saúde



SERVIÇOS DE SAÚDE – PORTA DE ENTRADA (APS, UPA, EMERGÊNCIA, HOSPITAIS, POLICLÍNICAS)

1 IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO



Identifique pacientes que atendam à definição de caso suspeito de Doença pelo Vírus **Bundibugyo (DVB)** - Ebola (conforme orientação vigente).

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO:

- ✓ Viagem, residência ou permanência nos últimos 21 dias em área com transmissão ativa da DVB OU exposição epidemiológica compatível com caso suspeito ou confirmado
- ✓ Febre e/ou calafrios

i Observação: o paciente ainda pode apresentar diarreia, vômitos, manifestações hemorrágicas, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, entre outros sintomas compatíveis.

⚠ Se NÃO preencher os critérios acima → seguir rotina assistencial habitual.

2 ISOLAMENTO IMEDIATO



- Realizar imediatamente o isolamento do paciente, preferencialmente em quarto privativo.
- Restringir acesso e circulação de pessoas na área.
- Definir a equipe que atenderá o paciente, restrita a um número mínimo de profissionais.
- Garantir banheiro exclusivo para o paciente.

PARAMENTAÇÃO DA EQUIPE

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| | Proteção para calçados | | ✓ Gorro cirúrgico |
| | Capote cirúrgico de mangas longas ou macacão impermeável | | ✓ Óculos ou protetor facial |
| | Máscara N95/PFF2 | | ✓ Luvas duplas |

✗ NÃO coletar amostras laboratoriais fora do hospital de referência.

3 NOTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO IMEDIATA (EM ATÉ 24 HORAS)



O profissional de saúde ou serviço que prestou o primeiro atendimento deve comunicar **IMEDIATAMENTE**:

CIEVS RIO
(pelo meio mais rápido disponível)

CONTATOS DO CIEVS RIO (24 horas/7 dias por semana)
 (21) 98000-7575 cievs.rio@gmail.com

Para realizar a notificação, utilizar a Ficha SINAN de Notificação Individual, assinalando o CID-10 A 98.4.

4 INVESTIGAÇÃO E REGISTRO



- Realizar entrevista epidemiológica detalhada.
- Verificar histórico de viagem e exposições de risco.
- Identificar e registrar contactantes/comunicantes:
 - Familiares ou conviventes
 - Profissionais de saúde
 - Equipe de transporte
 - Demais pessoas expostas



Encaminhar a listagem ao CIEVS para monitoramento por 21 dias.

5 ACIONAMENTO E TRANSFERÊNCIA



- A equipe CIEVS Rio, após ser acionada, entrará em contato com a equipe do CIEVS SES RJ, a qual acionará a equipe do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, para realizar a transferência do paciente até a unidade de referência.

! IMPORTANTE:

Evitar contato desnecessário com o paciente.

Limitar o número de profissionais expostos.

Realizar limpeza terminal do ambiente após a saída do paciente.

Descartar resíduos em sacos brancos leitosos identificados como infectantes.

Cumprir normas de biossegurança e protocolos institucionais vigentes.